

中山醫學大學附設醫院

主題名稱	經皮穿肝膽道引流管護理 Nursing Care of Percutaneous Transhepatic Cholangial Drainage				
編號	A31000-Q02-W-C08	制定者	N15 王素鴻	公布日期	99 年 04 月 20 日
制定單位	護理部	核准者	吳姿蓉	修正日期	112 年 07 月 04 日
版本/總頁數	第 3.5 版/7 頁	審查者	劉俞均	檢閱日期	114 年 06 月 05 日

一、目的

護理人員能正確執行經皮穿肝膽道引流管之護理。

二、範圍

護理部各單位（含中興分院）。

三、說明

（一）技術目的

1. 保持傷口清潔，預防傷口感染及早期發現感染徵象。
2. 觀察傷口是否有出血及滲液情形。
3. 保持管路暢通及預防管路滑脫。

（二）用物準備

1. 治療盤。
2. 消毒溶液：生理食鹽水及優碘藥水（視傷口及敷料種類來選擇）。
3. 消毒棉棒數包（視傷口狀況選擇種類或尺寸）。
4. 3×3 Y 紗一包、3×3 紗布數包。
5. 清潔手套。
6. Mefix 及 3M 透氣膠布。

（三）步驟及要點說明

步驟	說明
1. 核對 HIS 護理系統於護理執行，核對預定執行處方名稱、每次量、執行量、途徑、頻率，於核對狀態核簽“正確”。	
2. 洗手。	

主題名稱	經皮穿肝膽道引流管護理	制定單位	護理部		
編號	A31000-Q02-W-C08	版本	第 3.5 版	頁碼/總頁數	2/7

步驟	說明
3. 備妥用物，將換藥車（或護理工作車）推至病人單位。	
4. 辨識病人（至少二種以上方法），向病人及家屬解釋換藥的部位及過程。	1.病人辨識方法請依照護理作業常規A31000-Q02-W-A09「病人辨識作業標準」執行。 2.確認病人，建立安全感，取得病人信任。
5. 拉上床簾，露出傷口部分。	
6. 移除膠布及敷料： (1) 戴上清潔手套，一手固定皮膚，另一手由膠布兩側往傷口的方向，輕輕地撕下膠布。 (2) 抓住敷料的最外層輕輕取下。 (3) 檢視取下的敷料，觀察分泌物的量、氣味及顏色。 (4) 將敷料抓在手上，脫下手套將其包起來，丟至紅色感染性垃圾筒。	傷口與敷料發生沾粘，可用生理食鹽水濕潤後再取下，避免拉扯引流管。
7. 使用乾洗手液消毒雙手後，戴上清潔手套。	
8. 清潔與消毒傷口： (1)以無菌技術打開包裝及取出無菌棉棒。 (2)先用沾有生理食鹽水的棉棒由內往外環形清洗，連續清洗直到拭淨為止。 (3)再以沾有優碘的棉棒消毒傷口 2-3 次，使優碘溶液停留在傷口時間至少達 30 秒以上（重點是停留時間，而不是要消毒幾次）。 (4)以生理食鹽水棉棒由內往外環形清洗，連續清洗直到優點溶液拭淨為止。 (5)最後以乾棉棒將傷口周圍皮膚的溶液擦乾。	1. 清洗及消毒範圍至少大於傷口直徑 5 公分，清洗完後可執行傷口觀察及測量。 2. 消毒棉棒由內往外擦拭一次後即丟棄，切記勿來回擦拭，以防止污染傷口。
9. 以 Y 紗先固定管路，再蓋上 3×3 紗布以 Mefix 上下固定敷料，視情況在 PTCD 管路下段加黏 3M 固定。	1. 貼膠布的方向與肌肉走向呈垂直（較易固定）。 2. 敷料應大於傷口直徑 5 公分，以免傷口受污染。 3. 固定引流管時需注意不要讓病人容易壓到或扯到，亦不影響病人上下床的位置。
10. 協助病人整理衣物及單位。	
11. 清潔，整理及補充用物。	
12. 工作後洗手。	
13. 在 HIS 護理系統於護理執行，已完成執行處方醫囑，於執行狀態核簽“執行”及計價。	
14. 記錄：敷料滲出液的顏色、量及性質；傷口及	

主題名稱	經皮穿肝膽道引流管護理	制定單位	護理部		
編號	A31000-Q02-W-C08	版本	第 3.5 版	頁碼/總頁數	3/7

步驟	說明
周圍皮膚有無紅腫情形；引流液的顏色、量及性質。	

(四) 異常狀況處理說明

異常狀況	處理對策
滑脫： 經皮穿肝膽道引流管滑脫(包含自拔)可能原因： 1. 病人意識不清、躁動、不適等因素造成滑脫或自拔。 2. 不小心拉扯。 3. 膠布固定不佳引起。	1. 當管路滑脫或脫出時，應以無菌紗布覆蓋，立即通知醫師。 2. 衛教病人或主要照顧者經皮穿肝膽道引流管存放的必要性與重要性，並評估管路擺放的適當性，避免拉扯。 3. 評估約束的必要性。 4. 進入 HIS 異常事件通報系統進行通報管路事件。
阻塞： 可能原因：1.剛放置時，因血塊導致阻塞。 2.引流液太濃稠或有雜質。	通知醫師評估後，視情況協助醫師用生理食鹽水沖洗。
折曲： 可能原因：反折和纏繞。	使用安全別針將引流袋固定於衣服腰側處，應低於管路置放處。
感染症狀：傷口周圍紅腫熱痛或發燒之情形。	通知醫師，評估是否需做處理，如：抗生素治療、傷口細菌培養、血液培養、傷口切開引流、清創術等。

(五) 經皮穿肝膽道引流管管路的放置和注意事項

放置步驟	說明
1.隨時注意管路是否通暢，避免受壓、扭曲，保持引流管傷口清潔乾燥。	
2.經皮穿肝膽道引流管尺寸：Pig tail 8Fr。	
3.放置位置：醫師利用超音波導引，經皮穿肝將引流管置於肝內膽管內，並利用膽道攝影確定引流管位置後，將其固定於皮膚。管路拉出體表應以 Mefix 與 3M 進行固定牢固，以避免滑脫。若有滑脫情形應立即通知醫師。	 圖示：
4.正常情況下膽汁會逐漸變成金黃色，每日需記錄引流液的量及顏色，引流量每天約 400cc，若超過 1000c.c. 則須通知醫師。出院時，若管路帶回，須衛教病人每日記錄引流液的量及顏色。	

主題名稱	經皮穿肝膽道引流管護理	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q02-W-C08	版本	第 3.5 版	頁碼/總頁數	4/7

放置步驟	說明
5.若引流液量超過引流袋的 1/3～1/2，則需倒出。	
6.臥床休息時，採半坐臥式，維持引流袋低於管路放置處，請將引流袋掛於床邊的掛勾上，以免下床時不小心踩到引流袋，而使管路受到拉扯而脫落。	
7.引流袋勿放置於地上，以避免感染。	
8.下床活動時，請保持引流袋低於管路放置處，以免膽汁回流造成感染，並避免不小心的拉扯使管路外滑、脫落或傷口出血。	

(六) 實施及修訂

本辦法經護理長會議通過後，呈督導會議核准後公布實施，修正時亦同。

四、使用表單

(略)

五、流程圖

(略)

六、參考資料

- (一) 周成蕙、吳孟凌、洪雯娥、陳蓓蒂、呂桂雲、郝維君、趙淑賢、張美月、朱翠燕、周慧琄、黃惠萍、程仁慧(2022)・內外科護理・台北：華杏。
- (二) 林貴滿、李滿梅、林惠娟、譚蓉瑩、李素貞、陳秀蓉、陳佩英、張惠甄、韓玉蘭、蔡淑梅、曾錦瑋、洪麗珍、陳夏蓮、葉明珍、陳秋慧、顧家恬、古菊梅、鄧崇勵、賴美信...劉波兒(2021)・內外科護理技術・台北：華杏。
- (三) 羅心怡、林育嘉、張瑋、鄭青青(2022)・運用創造思考教學提升二年期護理師腹部引流管照護完整率。護理雜誌，69(5)，86-95。

主題名稱	經皮穿肝膽道引流管護理	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q02-W-C08	版本	第 3.5 版	頁碼/總頁數	5/7

七、附件

(略)

主題名稱	經皮穿肝膽道引流管護理	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q02-W-C08	版本	第 3.5 版	頁碼/總頁數	6/7

八、文件修正紀錄

修正日期	版本	修正說明	備註
99.04.20	1.0	新制定。	99 年 04 月 20 日 護理部照護標準 委員會通過。
99.08.31	2.0	配合本院 SOP 格式改版。	
100.04.06	2.1	修改目的與說明內容。	100 年 04 月 06 日 護理部照護標準 委員會通過。
102.02.26	3.0	配合標準化文件管理辦法修正公布日期及進行年度 臨時檢閱。	
103.06.30	3.0	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
104.06.02	3.1	1. 修改目的與說明內容；說明（三）步驟及要點說明：加入病人辨識方法依照護理作業常規 A31000-Q02-W-A09「病人辨識作業標準」執行；（四）異常狀況處理說明修改須進入 HIS 異常事件通報系統進行通報管路事件。 2. 新增第六項參考資料。	104 年 06 月 02 日 護理部照護標準 委員會通過。
105.06.07	3.1	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
106.06.05	3.2	原主題名稱經皮穿肝膽道引流管路護理；改為~經皮穿肝膽道引流管護理。	106 年 06 月 05 日 護理部照護標準 委員會通過。
107.06.04	3.2	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
108.06.06	3.3	1. 第二項新增（含中興分院）。 2. 第三項第二目之 2、3；第三項第三目之 6 刪除。 3. 第三項第二目之 6 刪除部份文字。 4. 第三項第二目之 7 新增 3×3 紗布數包。 5. 第三項第三目之 10；第三項第五目之 3 說明內容修訂。 6. 第三項第六日本辦法經委員會通過後公布實施，改為護理長會議通過後，呈督導會議核准後公布實施。	108 年 06 月 06 日 照護標準組會議 通過；108 年 06 月 12 日護理長會 議通過；108 年 06 月 18 日督導會議 通過公布。

主題名稱	經皮穿肝膽道引流管護理	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q02-W-C08	版本	第 3.5 版	頁碼/總頁數	7/7

修正日期	版本	修正說明	備註
109.06.04	3.3	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
110.07.08	3.3	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
111.07.05	3.4	第三項第二目用物準備刪除傷口換藥包（內含：有齒鑷、無齒鑷及換藥碗各一個）。	111 年 06 月 02 日照護標準組會議通過；111 年 06 月 08 日護理長會議通過；111 年 07 月 05 日督導會議通過公布。
112.07.04	3.5	新增第六項參考資料。	112 年 06 月 08 日照護標準組會議通過；112 年 06 月 14 日護理長會議通過；112 年 07 月 04 日督導會議通過公布。
113.04.30	3.5	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
114.06.05	3.5	年度檢閱，無修正。版本不變動。	